RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**INDIKASI / KRITERIA** **PASIEN MASUK ICU**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1255/2026	No.Revisi 02	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Suatu pedoman dalam mengatur pasien yang perlu dirawat di Intensif Care Unit(ICU)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk : 1. Petunjuk tetap tentang indikasi / kriteria untuk perawatan pasien di Intensif Care Unit. 2. Agar pasien dan keluarga mendapat pelayanan keperawatan dan dapat terlaksana dengan baik, cepat dan terarah sesuai dengan kondisi pasien.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	Kriteria pasien masuk Icu ada 3 kriteria 1. PRIORITAS 1 (SATU) Kelompok pasien sakit kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi, seperti dukungan/bantuan Ventilasi, alat penunjang sistem organ/sistem lain, infuse obat-obat vasoaktif/inotropik, obat anti aritmia, serta pengobatan lain secara kontinyu dan tertitrasi. Contoh: 1) Pasca bedah kardiotorasik 2) Sepsis berat (HR >; 100x/menit, Leukosite ≥ 15000 / < 4000, Suhu : >38 0 C, Lebih dari 2 orang yang kena) Septik syok (Ada tanda sepsis berat dan sudah di loding cairan dan Vasopresor

tetapi Hemodinamik tetap tidak naik).

3) Gangguan asam basa (PaO2 < 50 dan pH < 7.1 or >7.7) dan Gangguan elektrolit yang mengancam nyawa (Sodium / Na < 110 or >170, Potassium/K < 2.0 or >5.0 dan Calcium >15 mg/dL).
4) Hiperglikemi dengan kadar Glucose > 500 mg/dL dan Hipoglikemi yang sudah diterapi dan diresusitasi tetapi masih penurunan kesadaran.
5) Emergency Obstetri (Eklamsi Berat, Perdarahan, Sepsis dan PEB).

2. PRIORITAS 2 (DUA)

Kelompok pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU, misal pemantauan intensif menggunakan pulmonary arterial kateter. Sebab sangat beresiko bila tidak mendapat terapi intensif segera. Contoh:

1) Pasien menderita penyakit dasar jantung- paru (AF,VF Hemodinamik tidak stabil dengan sistol kurang dari 90 mmHg, ARDS / ALI dan khusus isolasi dengan TBC, Serosis yang bukan stadium terminal yaitu bukan)GCS < 5, bukan kelainan ≥ 2 organ, dan Dyspnoe dengan penurunan kesadaran).
2) Gagal ginjal akut dan berat
3) Pasien yang telah mengalami pembedahan mayor (Craniotomi, Laparatomi, Operasi Ginjal dengan gangguan hemodinamik dan pernafasan serta penurunan kesadaran).
4) Hipertensi krisis

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">INDIKASI / KRITERIA
PASIEN MASUK ICU</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

400.7.3.4 /1255 /
2026</td><td>No.Revisi

02</td><td>Halaman :

3/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">3. PRIORITAS 3 (TIGA)
Kelompok pasien sakit kritis, yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, yang disebabakan penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya, secara sendirian atau kombinasi. Contoh:
1) Pasien dengan keganasan disertai penyulit infeksi.
2) Sumbatan jalan nafas
3) Pasien penyakit jantung disertai komplikasi penyakit akut berat.
4) Penyakit paru disertai komplikasi penyakit akut berat
PENGECUALIAN (Pasien TIDAK Indikasi Masuk ICU)
1) Pasien yang memenuhi kriteria masuk tetapi menolak tunjangan hidup yang agresif dan hanya demi perawatan yang aman (DNR).
2) Pasien dalam keadaan vegetatif permanen (Cancer stadium Akhir, TBC stadium akhir, HIV AIDS
3) Pasien yang dipastikan mati batang otak namun hanya untuk kepentingan donor organ semata</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. ICU
2. IGD
3. IBS
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Rawat Jalan</td></tr>
</table>